

Información Paciente

Nombre : Osvaldo Guillermo Luis Meza Verdugo
Edad : 73a 9m 9d
Dirección : Av. El Peral 07250

Rut : 6.448.373-0
Fecha Nacto: 17/02/1951
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0620267
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 88993941

N° Epicrisis
421950

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 25/11/2024 07:09

Días Estadía: 1

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 26/11/2024 14:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

cirugía tumor periampular.

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Osvaldo Meza Verdugo / 6448373-0 / 73 años
0 días Piperacilina/tazobactam

ANTECEDENTES

MÉDICOS: HTA, DM2 IR, Hipotiroidismo. Cáncer de tiroides operado. Cáncer de páncreas actual.

QUIRÚRGICOS: Tiroidectomía, ERCP

FARMACOS: Insulina NPH, Dapagliflozina, metformina, losartan, levotiroxina 100mcg

ALERGIAS: No

HABITOS: No

Capacidad funcional (DASI 44,7 (8,28 mets)

HISTORIA

Paciente con antecedentes descritos con diagnóstico de cáncer de páncreas actual, ingresa electivo para cirugía de Whipple, con presencia de biliopus al momento de colecistectomía, desgarró de vena porta 80% requiere clamp de urgencia con posterior anastomosis termino terminal primaria, posteriormente se observa en Doppler intraoperatorio ausencia de flujo portal se realiza fogarty con salida múltiples coágulos por lo que finalmente se realiza puente de vena iliaca de donante, nueva anastomosis permeable, queda con laparotomía contenida, resto cirugía de whipple, se campleó sistema venoso portal en 3 oportunidades. Se recibe paciente en UCI, vasopléjico, mal perfundido a distal, pálido, icterico, hipotenso, hipotérmico, con triple DVA. De acuerdo a exámenes continuar reanimación con hemoderivados vs coloides. Discuto caso con jefatura y nefrología, solicito HFAV.

Recibe 11ui GR, 6 PFC, 1 pool de crioprecipitados, 1 pool de plaquetas, 12500ml ringer lactato, 1000ml S. NaCl 0.9%, 1000ml de HCO3 2/3M.

PROTOCOLO QUIRÚRGICO

Paciente bajo anestesia general, se realiza asepsia y antisepsia, colocación de campos estériles, se realiza laparotomía media supra umbilical, se comienza disección a transcavidad de los epiplones identificando tronco rastro cólico. Se disecciona cara inferior del páncreas identificando vena mesentérica superior. Posteriormente se realiza maniobra de Kocher amplia.

Se realiza colecistectomía en directa con vesícula a tensión y salida de biliopus el cual se envía a cultivo. Posteriormente se realiza disección de hilio hepático con extenso proceso inflamatorio indurado, se identifican arterias hepáticas derecha e

Fecha Epicrisis : 26/11/2024 14:14

Fecha Última Actualización: 26-11-2024 14:14:17

Página 2 de 3

izquierda, vena porta y vía biliar. Se realiza sección de vía biliar y se envía muestra de líquido a cultivo. Se realiza sección de yeyuno a 15 cm de treitz con carga azul y resección de duodeno con preservación de piloloro con carga azul. Posteriormente se comienza disección de proceso uncinado durante liberación de la pieza se presenta importante desgarro de vena porta aprox 80%. Clamp de urgencia con Satinsky. Se completa resección de pieza operatoria y se realiza resección de porta y anastomosis termino terminal primaria. Se realiza ecografía intraoperatoria con adecuado flujo intrahepatico. Se comienza reconstrucción en asa de child con anastomosis pancreatoyeyuno tipo blumgart. Páncreas duro con conducto de wirsung aprox 6 mm se posicionan 8 puntos de PDS 6; posteriormente derivación biliodigestiva con cara anterior y posterior con PDS 4. SE realiza gastro yeyuno con PDS 4 tipo Connel.

Posteriormente se realiza nueva ecografía intraoperatoria con ausencia de flujo portal por lo que se decide realiza embolectomía con fogarty y salida de coágulos múltiples sin adecuado flujo portal. Por lo que se decide realiza puente con vena iliaca de donante. Con anastomosis proximal a confluencia portal y anastomosis distal laboriosa a vena mesenterio superior. Dado difícil control se decide realizar ligadura de vena esplénica. Dado paciente en regular condición general. Se decide realizar laparotomía contenida y manejo en UCI. Drenaje JP al hilio.

Paciente muy grave, hdn inestable, 3 DVA NAD 0.6 ADN 0.6 Vasopresina 0.05, hemofiltración de alta volumen 8 hrs en transcurso.

Mal perfundido, Lactico 240, coagulópata, politransfundido, ecoscopia con signos de hipovolemia, drenajes con salida de contenido hemático + seroso.

sospecha de sangrado en relación a coagulopatía, se discute caso con equipo HPB, no se beneficiaría de reexploración dada la gravedad, posibilidad de fallecer tan solo en el traslado.

al EF:

pálido, bajo sedación, pupilas isocóricas, mióticas, frío a distal, abdomen muy distendido, no depresible.

Se da aviso a Hijo de la gravedad del paciente y pronóstico ominoso a corto plazo.

3) Antecedentes: HTA, DM2 IR, Hipotiroidismo. Cáncer de tiroides operado. Cáncer de páncreas actual.

26/11/24 13:05 Presenta para cardiorrespiratorio.

Fallece.

Diagnóstico de Egreso

TUMOR MALIGNO DE OTRAS PARTES ESPECIFICADAS DEL PÁNCREAS - DIAGNOSTICOS

1) Cirugía de Whipple por cáncer de páncreas.

- Shock hemorrágico. Protocolo transfusión masiva.

- Vasoplejia refractaria. Obs síndrome isquemia ¿, perfusión

2) Falla renal aguda.

3) Antecedentes: HTA, DM2 IR, Hipotiroidismo. Cáncer de tiroides operado. Cáncer de páncreas actual

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece 26/11/24 13:05

Plan Post Alta

Fallece 26/11/24 13:05

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 26/11/2024 14:14

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 26-11-2024 14:14:17

Página 3 de 3

INTERNO

Becado/Residente

Carlos Morales Mora

Médico Tratante (Staff)